# percorsi nella disabilità
# Dispensa ICF

**marzo 2026**

Perché conoscere l'ICF?

- È utile per la valutazione della situazione globale delle persone
- È utile per la definizione disabilità di ogni persona e la sua presa a carico
- È utile da un punto di vista pratico per:
    - la costruzione del PEI
    - la definizione degli obiettivi condivisi
    - la definizione delle azioni educative
    - l'osservazione delle azioni educative
    - la valutazione delle azioni educative
- È uno strumento riconosciuto internazionalmente
- Introduce un linguaggio condiviso
- È utile per la raccolta dei dati e per le ricerche

Cos'è L'ICF ?

- È la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) fa parte della Famiglia delle Classificazioni Internazionali dell'OMS
- Fu elaborata nel 2001 come strumento che analizza e descrive la disabilità come "esperienza", come " condizione" umana che tutti possono sperimentare

Il modello ICF si evolve a partire dal concetto di salute promossa dall'OMS:

- **"**La salute è una componente fondamentale della nostra vita. L'Organizzazione mondiale della sanità OMS la definisce «uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia (…) Secondo la definizione dell'OMS, (...) La salute è un concetto positivo che valorizza le risorse personali e sociali, come pure le capacità fisiche **"**

https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/temi/salute-e-promozione-della-salute.html

- Il concetto di salute definito dall'OMS si è evoluto dal significato di "assenza di malattia" ad un concetto più articolato e complesso che tende verso una piena armonia e un sano equilibrio fisico, psichico, spirituale e sociale.

Secondo l'OMS per definire lo stato di salute di una persona non basta solo l'esame clinico ed obiettivo (assenza di malattia, disturbi o lesioni...) ma è necessario considerare anche le dimensioni del suo funzionamento umano (fisico, psicologico, personale, familiare e sociale) e l'ambiente in cui vive.

- La salute non riguarda solo alcune parti di un individuo (fegato, polmoni..) ma è uno stato di piena forma dell'intera persona;
- La salute è essenzialmente legata al funzionamento umano a tutti i livelli (biologico, personale e sociale);
- La salute non può essere separata dal contesto o ambiente in cui la persona vive. La salute quindi interagisce con l'ambiente e l'ambiente interagisce con la salute;

- La salute è una risorsa per la vita quotidiana e non lo scopo dell'esistenza. Si tratta di un concetto positivo che valorizza le risorse sociali e personali, oltre alle capacità fisiche.

Ottawa Charter for Health Promotion. WHO, Geneva, 1986

- L'ICF appartiene alla famiglia delle classificazioni internazionali ed è stato realizzato dall'OMS. È uno **strumento utilizzato internazionalmente per descrivere, misurare e classificare salute e disabilità.** Tramite l'ICF è possibile ricavare informazioni strutturate sulla salute delle persone sia a livello delle funzioni (inclusa la sfera mentale) e delle strutture dell'organismo umano, sia a livello dell'attività di una persona e della sua partecipazione alle situazioni di vita.

**Con l'introduzione dell'ICF si assiste quindi ad un CAMBIO DI PARADIGMA:**

**si passa da modelli medici individuali e riabilitativi (DSM- ICD)**
**a modelli BIO-PSICO-SOCIALI (ICF- PPH)**

**in cui la persona è considerata nella sua completezza ed in relazione con IL CONTESTO.**

cambio di paradigma:

- Con l'ICF si analizza la vita delle persone, dei modi con cui esse convivono con le loro patologie e le affrontano in diversi contesti.
- **La disabilità è definita dalle relazioni che intercorrono tra le condizioni della persona e i fattori contestuali.**
- La persona non è abile o dis-abile, la persona ha delle caratteristiche che sono influenzate da fattori interni e/o esterni, caratteristiche e fattori ne definiscono il funzionamento e la partecipazione sociale.
- Tramite l'ICF è possibile individuare i punti di debolezza/deficit e anche di forza, i bisogni e le attitudini, il funzionamento o la disabilità.
- Si mettono in evidenzia le **risorse personali e contestuali**, presenti o necessarie, da potenziare o da attivare.

- L'ICF è un modello multidisciplinare e multidimensionale infatti integra **tre dimensioni**:

1. Quella **biologica** (condizioni di salute)
2. Quella **psichica** (fattori personali)
3. Quella **sociale** (fattori ambientali)

- L'ICF è un modello **interattivo** che considera le relazioni tra funzioni, strutture corporee, attività, partecipazione ed ambiente.
- Un'analisi senza **tutti** questi elementi non ci permetterebbe di valutare il funzionamento di una persona nella sua completezza, cioè sia a livello personale che nella partecipazione sociale.
- Esistono due versioni dell'ICF, quello classico e quello con dicitura ICF-CY (ovvero Children and Youth). Una prima traduzione italiana è del 2002 relativa alla prima edizione OMS del 2001.
- La prima versione si occupa prevalentemente della classificazione del funzionamento degli adulti, la seconda è una derivazione dell'ICF nata nel 2007 e si occupa degli standard di funzionamento dei bambini e dei giovani dai 0 ai 18 anni.
- Inoltre esiste una versione breve, con livelli di classificazione ridotti
- L' ICF fornisce sia un linguaggio unificato e standard, sia un modello concettuale di riferimento per la descrizione della salute e degli stati ad essa correlati.
- L'ICF è uno strumento utilizzato per le analisi e le ricerche.
- È considerata un complemento dell'*International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th revision* (ICD-10) che è una classificazione delle malattie internazionale pubblicato nel 1970 sempre dall'OMS. L'ICD serve per la diagnosi delle patologie, individua le cause (etiopatologia), descrive le principali caratteristiche e fornisce le indicazioni diagnostiche delle patologie, è un modello medico.

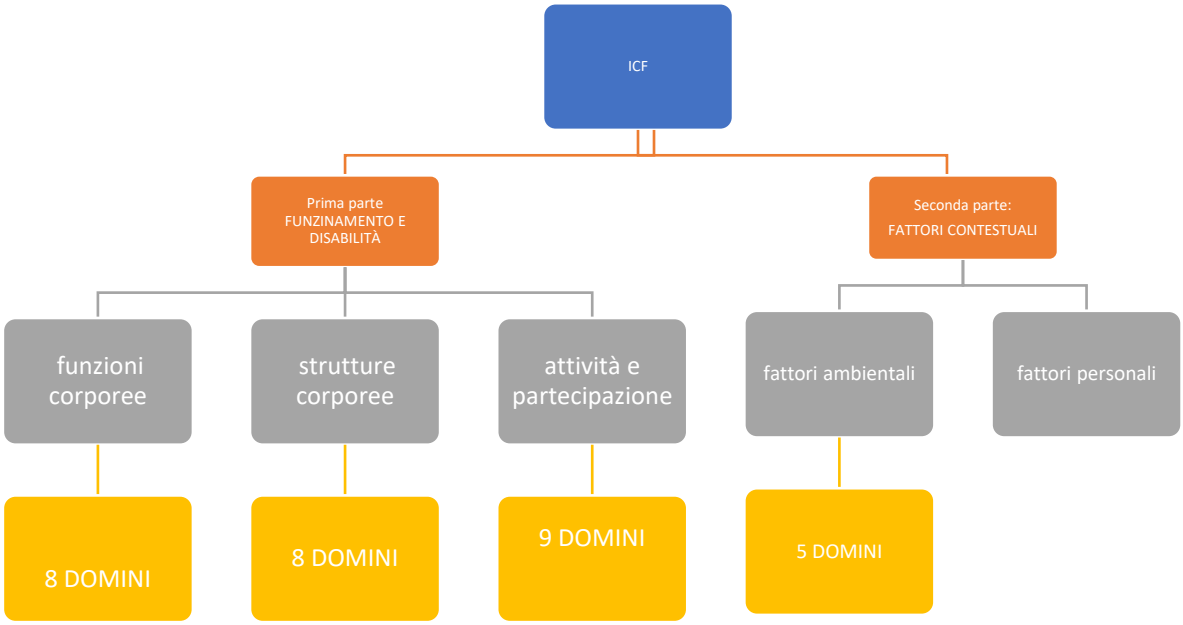
Come usare l'ICF?
- Partiamo dalla struttura

«Le infomazioni fornite dall'ICF sono una descrizione delle situazioni che riguardano il funzionamento umano e le sue restrizioni, e la classificazione serve da modello di riferimento **per l'organizzazione delle informazioni…»**

introduzione ICF

L'ICF organizza le informazioni in 2 parti, che a loro volta si dividono in componenti e descrivono ogni aspetto della persona dal punto di vista biologico, psicologico e sociale.

Le componenti si dividono ulteriormente in domini. I domini sono insiemi di funzioni fisiologiche, strutture anatomiche, azioni, compiti o aree della vita correlate tra loro e costituiscono i diversi capitoli e i blocchi all'interno di ciascuna componente.




Questa struttura permette di assegnare **un codice alfanumerico** a ciascuna delle possibili dimensione del funzionamento di una persona.
A ciascun codice si associa **un costrutto o qualificatore** in base alla valutazione dello stato di salute di una persona da parte di un operatore (sanitario, sociale, educativo ...).

- **La prima parte** è dedicata all'accertamento del funzionamento e delle disabilità suggerendo un elenco e una classificazione delle **funzioni e delle strutture corporee, delle attività quotidiane** che generalmente le persone sono chiamate a svolgere e dei livelli di partecipazione.
- **La seconda parte** elenca i **fattori contestuali** che possono esercitare impatti significativi sulla vita delle persone. Vengono considerate sia le componenti fisiche e sociali degli ambienti di vita, sia i fattori personali.

**TABELLA 1**
**Interrelazione dinamica delle componenti**

| | Parte 1: Funzionamento e disabilità | | Parte 2: Fattori contestuali | |
|---|---|---|---|---|
| **Componenti** | **Funzioni e Strutture Corporee** | **Attività e Partecipazione** | **Fattori Ambientali** | **Fattori Personali** |
| **Domini** | Funzioni Corporee<br>Strutture Corporee | Aree di vita (compiti, azioni) | Influenze esterne su funzionamento e disabilità | Influenze interne su funzionamento e disabilità |
| **Costrutti** | Cambiamento nelle funzioni corporee (fisiologico)<br>Cambiamento nelle strutture corporee (anatomico) | Capacità: eseguire compiti in un ambiente standard<br>Performance: eseguire compiti nell'ambiente attuale | Impatto facilitante o ostacolante delle caratteristiche del mondo fisico, sociale e degli atteggiamenti | Impatto delle caratteristiche della persona |
| **Aspetto positivo** | Integrità funzionale e strutturale | Attività<br>Partecipazione | Facilitatori | Facilitatori |
| | Funzionamento | | | |
| **Aspetto negativo** | Menomazione | Limitazione dell'attività<br>Restrizione della partecipazione | Barriere/ostacoli | Barriere/ostacoli |
| | Disabilità | | | |

PRIMA PARTE

**Le funzioni corporee**: sono le funzioni fisiologiche dei sistemi corporei (incluse le funzioni psicologiche)*

Sono divise in 8 domini:
1- funzioni mentali (globali e specifiche: coscienza, orientamento, intellettive, sonno, attenzione, memoria…)
2- funzioni sensoriali e dolore (sensoriali e dolore)
3- funzioni della voce e dell'eloquio (articolazione, fluidità…)
4- funzioni del sistema cardiovascolare, ematologico, immunologico e respiratorio (esercizio fisico, sensazioni associate…)
5- funzioni dell'apparato digerente e dei sistemi metabolico ed endocrino (ingestione, digestione, metaboliche…)
6- funzioni genitourinarie e riproduttive
7- funzioni neuro – muscoloscheletriche e correlate al movimento (articolazioni, ossa,muscoli, movimento)
8- funzioni della cute e strutture correlate (cute, peli, capelli, unghie)

* definizione introduzione ICF

**Attività e partecipazione** sono rispettivamente:

- L'esecuzione di un compito o di un'azione da parte di un individuo
- Il coinvolgimento in una situazione di vita*

Sono divise in 9 domini:
1- apprendimento e applicazione delle conoscenze (guardare,ascoltare, copiare…)
2- compiti e richieste generali (intraprendere, gestire, eseguire)
3- comunicazione (ricevere, produrre, conversare…)
4- mobilità (camminare,trasportare, cambiare mantenere posizione…)
5- cura della propria persona (lavarsi, vestirsi, mangiare…)
6- vita domestica (procurarsi i beni, svolgere compiti, prendersi cura)
7- interazioni e relazioni interpersonali (entrare in relazioni e semplici, complesse, formali, intime…)
8- aree di vita principali (istruzione, lavoro, vita economica)

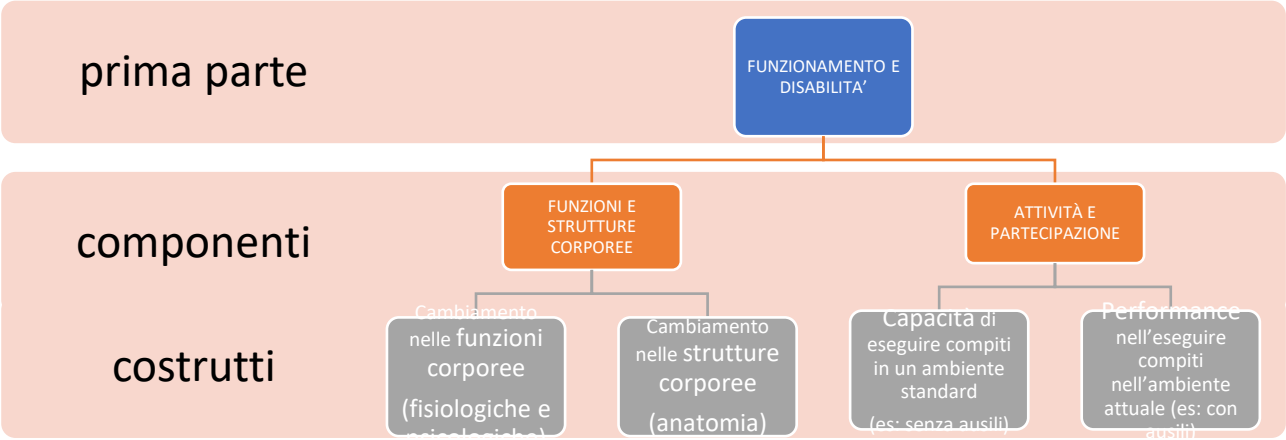
9- vita sociale, civile e di comunità (ricreazione, diritti, religione)

* definizione introduzione ICF

- **Attività e partecipazione** sono osservate nei vari contesti di vita e poi qualificate **distintamente in PERFORMANCE** (osservazione in ambiente attuale, magari adattato) **O CAPACITÀ** (osservazione in ambiente standard**).**

La **performance** è ciò che una persona effettivamente fa. Essa appare quindi come risultato dell'interazione dei fattori ambientali sul funzionamento, ed è quindi strettamente dipendente dall'ambiente. La performance descrive quello che l'individuo fa nel suo ambiente attuale e reale, e quindi introduce l'aspetto del coinvolgimento di una persona nelle situazioni di vita. Tramite essa, è possibile valutare il grado di difficoltà incontrato dalla persona nello svolgere attività e azioni di partecipazione alla vita sociale nei suoi contesti di vita abituali con i sostegni in atto.

La **capacità** è ciò che una persona può fare ed è una caratteristica intrinseca di quella persona. Essa quindi è indipendente dall'ambiente e descrive il funzionamento della persona in un ambiente neutro che non facilita e non ostacola. Indica il più alto livello probabile di funzionamento che una persona può raggiungere in un momento determinato in un dominio.




L'insieme delle componenti descritte finora (cioè funzioni e strutture corporee da un lato e attività e partecipazione dall'altro) nella sua espressione positiva esprime il funzionamento, mentre in accezione negativa esprime la disabilità; funzionamento e disabilità costituiscono la prima parte della classificazione.

SECONDA PARTE

**Fattori contestuali** che includono i fattori ambientali e i fattori personali.

I **fattori ambientali (influenze che arrivano dall'esterno)** sono gli atteggiamenti, l'ambiente fisico e sociale in cui le persone vivono e conducono la loro esistenza*

sono di visi in 5 capitoli :
1- prodotti e tecnologia
2- ambiente naturale e cambiamentti effettuati dall'uomo
3- relazioni e sostegno sociale
4- atteggiamenti
5- servizi, sistemi e politiche

* definizione introduzione ICF

**I fattori personali (influenze che arrivano dall'interno)** sono il backgound personale della vita e dell'esistenza dell'individuo e rappresentano quelle caratteristiche dell'individuo ... I fattori personali non sono classificati nell'ICF…*

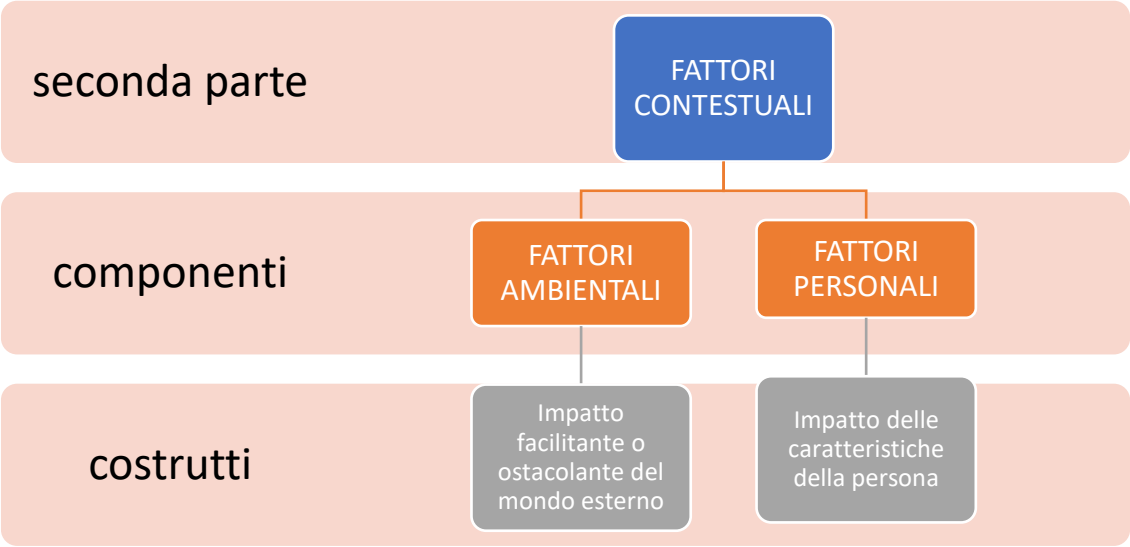
Possiamo considerare fattori personali:

Sesso, razza, età, forma fisica, stile di vita, abitudini, educazione, capacità di adattamento, backgaound sociale,, istruzione, professione, esperienze, modelli, stile caratteriale…non classificabili ed elencabili a causa della loro grande varietà

* definizione introduzione ICF

Nella seconda parte, si trovano i **fattori ambientali e personali**, cioè i **fattori contestuali**.

Che interagiscono con tutte le componenti del **funzionamento e della disabilità** e infatti possono avere ripercussioni positive **(facilitatori)** o negative **(barriere)** sullo stato di salute.



## Come usare l'ICF, LA CODIFICA E I QUALIFICATORI

L'ICF adopera un sistema alfanumerico nel quale le lettere indicano le componenti: **b** (body), **s** (structure), **d** (domain), **e** (environment):

- **b** le Funzioni Corporee (parte 1)
- **s** le Strutture Corporee (parte 1)
- **d** le Attività e la Partecipazione (parte 1)
- **e** i Fattori Ambientali (parte 2)

All'interno di ognuna sono presenti delle sotto-componenti per livelli di progressiva specificazione.

Le lettere sono quindi seguite da un codice numerico che inizia con il numero del capitolo (una cifra), seguito dal secondo livello (due cifre) e dal terzo e quarto livello (una cifra ciascuno).

Esempio: s2204 cristallino. (s2 occhio, orecchio e strutture correlate, s220 struttura del bulbo)



### CAPITOLO 2 OCCHIO, ORECCHIO E STRUTTURE CORRELATE

s210 [redacted] della cavità orbitaria

s220 [redacted] del bulbo oculare

| | |
|---|---|
| s2200 | Congiuntiva, sclera, coroide |
| s2201 | Cornea |
| s2202 | Iride |
| s2203 | Retina |
| s2204 | Cristallino |
| s2205 | Corpo vitreo |
| s2208 | Struttura del bulbo oculare, altro specificato |
| s2209 | Struttura del bulbo oculare, non specificato |

Esempio: **b** 167, Funzioni mentali del linguaggio.

Funzioni mentali specifiche del riconoscimento e dell'utilizzo dei segni, simboli e altri componenti di un linguaggio.

- b 1670 recepire il linguaggio
- b 16700 recepire il linguaggio verbale.

Le categorie dell'ICF sono inserite l'una nell'altra in modo che le categorie più ampie includano sottocategorie più dettagliate.*

* introduzione ICF

**b164 [redacted] cognitive di livello superiore**
Funzioni mentali specifiche dipendenti in particolar modo dai lobi frontali del cervello, che includono comportamenti complessi diretti allo scopo come la capacità di prendere una decisione, il pensiero astratto, la pianificazione e la realizzazione di progetti, la flessibilità mentale e la capacità di decidere i comportamenti appropriati alle circostanze; spesso chiamate funzioni esecutive.
*Inclusioni:* *funzioni dell'astrazione e dell'organizzazione delle idee; gestione del tempo, insight e giudizio; formazione di concetti, categorizzazione e flessibilità cognitiva*
*Esclusioni:* *funzioni della memoria (b144); funzioni del pensiero (b160); funzioni mentali del linguaggio (b167); funzioni di calcolo (b172)*

**b1640 Astrazione**
Funzioni mentali del creare idee, qualità o caratteristiche generali a partire da, e distinte da, realtà concrete, oggetti specifici o casi effettivi.

**b1641 Organizzazione e pianificazione**
Funzioni mentali del coordinare le parti in un tutto unico e sistematizzarle; la funzione mentale implicata nello sviluppare un modo di procedere o di agire.

**b1642 Gestione del tempo**
Funzioni mentali dell'ordinare gli eventi in una sequenza cronologica, assegnando una certa quantità di tempo a eventi e attività.

**b1643 Flessibilità cognitiva**
Funzioni mentali del cambiare strategie, o variare inclinazioni mentali, come nella soluzione di problemi.

**b1644 Insight**
Funzioni mentali della consapevolezza e comprensione di se stessi e del proprio comportamento.

**b1645 Giudizio**
Funzioni mentali implicate nel discriminare e valutare delle diverse opzioni, come quelle coinvolte nel formarsi un'opinione.

**b1646 Soluzione di problemi**
Funzioni mentali dell'identificare, analizzare e integrare in una soluzione delle informazioni incongruenti o in conflitto.

**b1648 Funzioni cognitive di livello superiore, altro specificato**

**b1649 Funzioni cognitive di livello superiore, non specificato**

**b167 [redacted] mentali del linguaggio**
Funzioni mentali specifiche del riconoscimento e dell'utilizzo di segni, simboli e altre componenti di un linguaggio.
*Inclusioni:* *funzioni relative al recepire e decodificare il linguaggio verbale, scritto o in altre forme, come il linguaggio dei segni; funzioni di espressione di linguaggio verbale, scritto o in altre forme; funzioni integrative di linguaggio, orali e scritte, come quelle coinvolte nell'afasia recettiva, espressiva, di Broca, di Wernicke e di conduzione*
*Esclusioni:* *funzioni dell'attenzione (b140); funzioni della memoria (b144); funzioni percettive (b156); funzioni del pensiero (b160); funzioni cognitive di livello superiore (b164); funzioni di calcolo (b172); funzioni mentali di sequenza dei movimenti complessi (b176); Capitolo 2 – Funzioni sensoriali e dolore; Capitolo 3 – Funzioni della voce e dell'eloquio*

**b1670 Recepire il linguaggio**
Funzioni mentali specifiche della decodifica di messaggi in forma orale, scritta o altra, come il linguaggio dei segni, per ottenere il loro significato.

**b16700 Recepire il linguaggio verbale**
Funzioni mentali della decodifica di messaggi orali per ottenere il loro significato.

**b16701 Recepire il linguaggio scritto**
Funzioni mentali della decodifica di messaggi scritti per ottenere il loro significato.

**b16702 Recepire il linguaggio dei segni**
Funzioni mentali della decodifica di messaggi in linguaggi che utilizzano segni compiuti con le mani e altri movimenti per ottenere il loro significato.

**b16703 Recepire il linguaggio gestuale**
Funzioni mentali della decodifica di messaggi espressi con gesti non formalizzati fatti con le mani e con altri movimenti per ricavarne il significato.

**b16708 Recepire il linguaggio, altro specificato**

**b16709 Recepire il linguaggio, non specificato**

**b1671 Espressione del linguaggio**
Funzioni mentali specifiche necessarie per produrre messaggi significativi in forma orale, scritta, mediante il linguaggio dei segni o altre forme di linguaggio.

**b16710 Espressione del linguaggio verbale**
Funzioni mentali necessarie per produrre messaggi verbali significativi.

**b16711 Espressione del linguaggio scritto**
Funzioni mentali necessarie per produrre messaggi scritti significativi.

**b16712 Espressione del linguaggio dei segni**
Funzioni mentali necessarie per produrre messaggi significativi in linguaggi che utilizzano segni compiuti con le mani e altri movimenti.

**b16713 Espressione del linguaggio gestuale**
Funzioni mentali necessarie per produrre messaggi mediante gesti non formalizzati fatti con le mani e con altri movimenti.

**b16718 Espressione del linguaggio, altro specificato**

**b16719 Espressione del linguaggio, non specificato**

**b1672 Funzioni linguistiche integrative**
Funzioni mentali che organizzano significato semantico e simbolico, struttura grammaticale e idee, per la produzione di messaggi in forma verbale, scritta o altre forme di linguaggio.

**b1678 Funzioni mentali del linguaggio, altro specificato**

**b1679 Funzioni mentali del linguaggio, non specificato**

**b172 [redacted] di calcolo**
Funzioni mentali specifiche di determinazione, approssimazione e utilizzo di simboli e processi matematici.

La codifica in sé non assume significato se priva di una valutazione che esprima il grado di difficoltà che quella persona manifesta in uno specifico ambito del suo stato di salute e all'interno di una particolare interazione con l'ambiente in cui vive.

La descrizione dei domini della salute e di quelli ad essa correlati si riferisce al loro uso in un dato momento (come un'istantanea). E' possibile tuttavia descrivere una traiettoria nel tempo e nel corso dei processi registrando punteggi in momenti diversi.

I costrutti assumono significato, utilizzando i **qualificatori** che offrono un valutazione

I qualificatori sono:

- **Codici numerici** che specificano l'estensione o la gravità del funzionamento o della disabilità
- **Codici numerici** che indicano il grado in cui un fattore ambientale rappresenta un facilitatore (+) o una barriera.
- qualificare l'informazione significa misurare l'entità della difficoltà che una persona manifesta in un determinato aspetto del suo funzionamento.
- I codici ICF richiedono l'uso di uno o più qualificatori che denotano l'entità del livello di salute; ogni codice è qualificato secondo una struttura numerica che definisce la gravità della difficoltà.
- Dopo il codice si scrive un punto e poi il qualificatore pertinente alla componente che si sta esaminando

- Attività e partecipazione sono definite con due qualificatori, che indicano, sempre su 5 livelli, rispettivamente la «capacità» e la «performance» della persona.
- I fattori Ambientali hanno un solo qualificatore: barriere o facilitatori del funzionamento della persona ( + o -).

- Un **facilitatore** è un fattore ambientale in grado di modificare in termini positivi il funzionamento della persona in una specifica attività.

- Sono fattori che mediante la loro presenza migliorano il funzionamento e riducono la disabilità, possono evitare che una menomazione o una limitazione diventino una restrizione della partecipazione

- Una **barriera** è invece un fattore nell'ambiente di un individuo che limita il suo funzionamento e crea o amplifica la disabilità.
- Sono fattori che mediante la loro presenza limitano il funzionamento e creano disabilità, sono ostacoli all'attività e alla partecipazione

Nel nostro lavoro, la valutazione puo' servire per la progettazione del PEI e degli interventi che, a partire dalla condizione complessiva di vita di una singola persona, tendano a:

- ridurre l'impatto delle difficoltà di una persona sui suoi livelli di partecipazione sociale;
- potenziare le sue risorse e ad utilizzare le sue capacità;
- individuare in che modo le barriere ambientali, sociali e psicologiche la condizionano;
- Definire il PEI
- ricercare strumenti e tecniche per lo svolgimento del PEI

Dalla qualificazione, a dipendenza del costrutto potrebbe seguire:

- una menomazione (funzioni, strutture del corpo)
- una limitazione (nell'eseguire un'attività)
- una restrizione (partecipazione, coinvolgimento)
- una barriera (fattori contestuali)

# PER CONCLUDERE

*…noi siamo parte e siamo responsabili dell'ambiente, lasciamo il segno per come siamo e come agiamo.*

BIBLIOGRAFIA :
Ianes D (2004), La diagnosi funzionale secondo l'ICF, Erickson
OMS (2001), *Classificazione internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF)*, Erickson
Check List – Versione Breve PDF- who.int